

儿童侵袭性纤维瘤预后影响因素分析

袁鲁明, 曹 玲, 王佩国

[摘要] 目的:分析儿童侵袭性纤维瘤的预后影响因素。方法:回顾性分析某肿瘤医院 1980 年 1 月—2005 年 12 月收治的儿童侵袭性纤维瘤 33 例,对可能影响患儿局部复发的因素,包括年龄、性别、肿瘤的部位、大小、就诊之前是否曾经复发、切缘情况、是否行放疗等进行 Log-Rank 单因素及 Cox 比例风险分析。结果:影响肿瘤局部复发率的因素为切缘情况及复发史($P < 0.05$);性别、年龄、肿瘤大小、肿瘤位置及有无行放疗与复发率均无显著相关性($P > 0.05$)。对切缘情况及复发史再进行 Cox 比例风险分析,结果显示,两个因素均不是肿瘤复发的独立预后因素($P > 0.05$)。结论:切缘情况及治疗前是否曾经复发为影响预后的主要因素,应尽早行根治性切除。

[关键词] 侵袭性纤维瘤;治疗;复发

[中国图书分类号] R 730.262

[文献标识码] A

[文章编号] 1000-9736(2011)12-1088-03

侵袭性纤维瘤病或硬纤维瘤是临床罕见疾病,约占有所有肿瘤的 0.03%^[1]。目前认为是起源于肌腱膜结构,由成纤维细胞的过度增殖形成。常因病理检查时细胞显示正常的有丝分裂,且临床上未发现远处转移而被认为是良性病变。但该病具有局部侵袭性,肿瘤无被膜,术中可见常与周围肌肉、神经等粘连紧密,即使行广泛切除也容易复发,具有部分恶性肿瘤的特点^[2]。儿童侵袭性纤维瘤更为罕见,目前仅见少量个案报道。我们回顾性分析了 1980 年 1 月—2005 年 12 月,某肿瘤医院收治的儿童侵袭性纤维瘤的临床特征及预后的影响因素。现报告如下。

1 对象和方法

1.1 对象 选择某肿瘤医院 25 年间收治的儿童侵袭性纤维瘤 33 例,其中男 17 例,女 16 例;年龄 3~18 岁,平均 12.5 岁,其中 12~18 岁 22 例(66.7%)。肿瘤部位:头颈 4 例,躯干 11 例,四肢 18 例(其中上肢 6 例,下肢 12 例)。肿瘤直径 1~20 cm,≤5 cm 者 12 例,占 35.3%;>5 cm 者 21 例,占 64.7%,其中≥10 cm 的巨大肿瘤 9 例(27.2%)。所有入组病例均无肿瘤家族史,肿瘤部位附近有明确外伤史 2 例。患者多因无意中发现局部不能推动的硬性肿块就诊,往往无其他自觉症状。曾于外院就诊 16 例,因复发入我院,其中复发 2 次及以上者 7 例。有明显疼痛等症状者,术中均可见到肿瘤侵及神经,或压迫相邻器官。

1.2 方法 记录患者的年龄(初次接受治疗的年龄)、性别、肿瘤家族史、外伤史、症状、体征、肿瘤大小、部位、复发次数及治疗方式等。所有患者均经病理学检查证实,外院诊断者病理资料均经我院病理科复检。

1.3 治疗及随访 (1)治疗。入组病例均接受手术治疗,行扩大及广泛切除术 7 例,行肿物切除术 20 例,行部分肿物切除术 6 例。接受放疗 11 例,其中行术中粒子置入术 2 例,余均为术后放疗。采用 ^{60}Co 或 6~8 MV X 线外照射,中位放疗剂量 50 Gy(30~60 Gy)。均未行化疗及内分泌治疗。(2)随访。1998 年以前就诊的病例采用信件随访,1998 年以后的病例采用电话随访。随访时间 6~122 个月,中位随访时间 75 个月。共失访 2 例,随访率 94%。

1.4 复发标准及影响因素 复发定义为临床检查或影像学发现肿物复长。随访时间从最后一次治疗结束开始至随访结束日期即 2010 年 1 月。分析因素有患者年龄、性别、肿瘤的部位、大小、就诊之前是否曾经复发、切缘情况、是否行放疗。其中年龄为入我院就诊时初次诊治的年龄,肿瘤大小取肿瘤的最长径。切缘情况中,镜下阳性及大体肿物残留阳性均属于切缘阳性。

1.5 统计学处理 采用 SPSS 16.0 软件包进行统计学处理,生存率计算采用 Kaplan-Meier 方法,组间比较应用 Log-Rank 检验,多因素分析采用 Cox 比例风险回归方法,以 $P < 0.05$ 为差异或相关显著。

2 结果

2.1 随访结果 随访期间未发生死亡及转移病例。发生局部复发 9 例,且均在 5 年内,中位复发时间 18 个月(8~45 月),1 年、3 年、5 年期复发率分别为 9.4%、22.4%、29.8%,且复发部位几乎均在原处,或原位附

作者单位:071000 河北保定,解放军 252 医院放疗中心(袁鲁明);天津,天津医科大学附属肿瘤医院放疗科(曹玲,王佩国)

通讯作者:王佩国, E-mail: wangpeiguo@yahoo.com.cn

近;出现多发复发肿物 1 例。随访中,出现明显并发症 4 例,其中,头颈部单纯手术 1 例,因肿瘤较大,术中伤及面神经导致面部麻木、感觉障碍;其余 3 例均为辅助放疗者,伤口难以愈合 1 例,肌肉萎缩、乏力、肌肉较对侧细 1 例,关节纤维化 1 例。

2.2 预后因素相关分析结果 以性别、年龄、肿瘤大小、肿瘤位置、切缘情况、复发史、有无放疗等为自变量,以肿瘤复发为因变量,进行 Log-Rank 单因素分析。结果显示,显著影响局部复发率的因素为切缘情况及复发史($P < 0.05$);性别、年龄、肿瘤大小、肿瘤位置及有无行放疗均无显著相关性($P > 0.05$)。对切缘情况及复发史再进行 Cox 比例风险分析,结果显示,两个因素均不是肿瘤复发的独立的预后因素($P > 0.05$)。

表 1 儿童侵袭性纤维瘤预后危险因素 Log-Rank 单因素分析结果

项 目	例数	5 年局部复发率(%)	P 值
性别			Q 382
男	17	24.4	
女	16	35.4	
年龄			Q 922
0~11 岁	11	28.4	
12~18 岁	22	30.7	
肿瘤大小			Q 287
<5cm	12	18.2	
≥5cm	21	36.8	
肿瘤部位			Q 466
非四肢	15	21.4	
四肢	18	37.3	
切缘情况			Q 026
阴性	18	12.9	
阳性	14	50.0	
不详	1	0	
之前有无复发			Q 007
无	17	8.1	
有	16	51.4	
有无放疗			Q 992
无	22	31.3	
有	11	27.3	

3 讨 论

侵袭性纤维瘤病因不明,可能与物理、遗传和内分泌异常等因素有关。一般病理特征为肉眼见肿物往往形态不规则,切面灰白,成交错编织状。显微镜下,肿瘤有丰富的胶原纤维和极少的纤维细胞构成,平行排

列,细胞有异形性和核分裂象,肿瘤边缘常可见到被肿瘤组织包绕的横纹肌小岛。该病发生率较低,临床对此病的临床特征及预后因素了解不多。青春期(12~18 岁)儿童侵袭性纤维瘤发病率高,可能与此时患者内分泌情况变化较大有关。这与 Hani 等^[1]研究结果一致。一般儿童患者肿瘤体积较大,本研究中,肿瘤长径≥5 cm 者有 21 例;侵袭性纤维瘤几乎可以见于全身各处,多发生于四肢,肿瘤发生于四肢者 18 例,占 54.5%,且位于四肢者肿瘤体积较大,手术中往往因保存肢体功能导致无法手术切净,使其局部复发率较高。

关于儿童侵袭性纤维瘤的治疗文献报道较少。目前临床上仍以手术治疗为主,现有的文献报道多认为,儿童患者可能更具有侵袭性而且更难控制^[4]。本研究发现,切缘阴性及切缘阳性的局部复发率分别为 12.9%、50.0%。此外,曾经复发者较首诊者更易再次复发,两者局部复发率分别为 51.4%和 8.1%,与国外研究结果一致^[9]。不完善的手术可能导致肿瘤更快复发,增加肿瘤的侵袭能力,为进一步治疗带来困难。大部分患儿在术后 3 年内复发,所以在儿童首诊术后 3 年内应该行密切随访观察。Faulkner 等^[5]回顾性分析≤20 岁的儿童侵袭性纤维瘤 63 例,发现性别、年龄、肿瘤大小、肿瘤部位及之前复发次数均对局部预后无显著影响,切缘阳性对预后影响显著。Lawrence 等对 24 例儿童患者进行分析,结果显示,手术切缘情况为影响此病预后的惟一因素,在 3 年随访过程中,切缘阴性及切缘阳性的局部复发率分别为 15%及 70%。

切缘阳性患者的局部复发率较高,提示对切缘阳性者应高度重视辅助治疗。在成年人,切缘阳性的标准治疗为术后辅助放疗,其局部控制率均可达到 80%^[6]。而放疗在儿童患者的使用及作用评价应有别于成年人,因为若要达到局部控制,剂量往往需 50 Gy 以上,但由此带来的不良反应也显著增多,另外,放疗对儿童生长发育的影响更是明显。本研究有明显不良反应的 4 例中,3 例是因行放疗引起,其中行术中粒子置入术的 1 例患儿,随访中出现了较严重的不良反应。此外,放疗对儿童患者的治疗效果仍不明确。Merchant 等^[4]报道,儿童侵袭性纤维瘤 13 例,行术后放疗后复发 11 例(84.6%),其中接受 50 Gy 以上剂量照射的 8 例患者中,复发 6 例(75.0%)。本研究中,也未发现术后放疗者的预后优于单纯手术者。也有研究认为,放疗为无法达到根治性切除后的关键治疗。Jabbari 等^[7]对 13 例复发患者行补救治疗,未放疗的 7 例患者再次复发 5 例,而补救治疗中包括放疗的 8 例仅

有 1 例再复发。考虑到各文献报道中分析的年龄段及治疗方法差异较大,所以放疗对于儿童侵袭性纤维瘤的治疗效果还需要进一步探讨。

化疗及其他系统性治疗可能是除放疗之外的辅助治疗方式。烷化剂及蒽环类药物对儿童侵袭性纤维瘤疗效较好^[5]。但是对局部侵袭性的疾病使用全身系统性的治疗,所带来的收益是否大于其所造成的不良反应(如肝肾毒性)还需要进一步研究。有文献^[8]报道认为,现阶段仍采用的一些低毒性的化疗药物,如长春新碱及甲氨蝶呤等辅助化疗的有效率可达 50%。近来不少文献报道此病与家族性腺瘤性息肉病(FAP)关系密切^[3,10],但本次入组病例均无 FAP 病史。可能与对此病与 FAP 的关系了解不够,临床漏查有关。

儿童侵袭性纤维瘤临床上较为罕见,本研究结果显示,切缘情况及治疗前是否曾经复发为影响预后的主要因素,所以应尽早行根治性切除。因肿瘤体积大或侵及重要器官等无法根治性切除的病例,可予部分肿物切除暂行观察治疗,密切随访。放疗影响儿童生长发育,且并发症发生率较高,对儿童侵袭性纤维瘤应有选择地进行,建议作为复发者的挽救治疗方法之一。

参 考 文 献

- [1] Hani S,Zadeh T. Desmoid tumors of the Pediatric Mandible[J]. Ann Plast Surg,2009,62(2): 213-219.
- [2] de Bree E,Keus R,Melissas J,*et al.* Desmoid tumors: Need for an in-

- dividualized approach[J]. Expert Rev Anticancer Ther,2009,9(4): 525-535.
- [3] Levefre JH,Parc Y,Kerneis S,*et al.* Risk factors for development of desmoids tumours in familial adenomatous polyposis[J]. Br J Surg, 2008,95(9):1136-1139.
- [4] Merchant TE,Nguyen D,Walter AW,*et al.* Long-term results with radiation therapy for pediatric desmoid tumors[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys,2000,47(5):1267-1271.
- [5] Faulkner LB,Hajdu SI,Kher U,*et al.* Pediatric desmoids tumor: Retrospective analysis of 63 cases[J]. J Clin Oncol,1995,13(11): 2813-2818.
- [6] Micke O,Seegenschmiedt MH. Radiation therapy for aggressive fibromatosis(desmoid tumors)——results of a national patterns of care study[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys,2003,57(Suppl):2-5.
- [7] Jabbari S,Andolino D,Weinberg V,*et al.* Successful treatment of high risk and recurrent pediatric desmoids using radiation as a component of multimodality therapy[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2009,75(1):177-182.
- [8] Janinis J,Patriki M,Vini G,*et al.* The pharmacological treatment of aggressive fibromatosis: A systematic review[J]. Ann Oncol,2003,14: 181-189.
- [9] Baumert BG,Spahr MO,von Hochstetter A,*et al.* The impact of radiotherapy in the treatment of desmoids tumours. An international survey of 110 patients: A study of the rare cancer network[J]. Radiation Oncol,2007,2(12):42-52.
- [10] Kotilgim D,Lazar AJ,Pollock RE,*et al.* Desmoid tumor: A disease opportune for molecular insights[J]. Histol Histopathol,2008,23 (2):117-126.

(收稿:2011-06-13 修回:2011-09-19 编校:刘慧铭)

读者·作者·编者

《人民军医》杂志声明

近来,编辑部发现有的作者稿件存在一稿多投和明显抄袭的现象,严重违背了学术道德,侵犯了他人著作权,影响了刊物的形象。根据《出版管理条例》《著作权法》和其他期刊出版有关规定,本刊对抄袭和一稿多投问题声明如下:(1)凡投予本刊的稿件,文中引用他人文献的资料和观点,应加以注释;若大段引用而未加以注释,即视为抄袭。(2)如果 2 篇稿件在文字表达和讨论叙述上存在某些不同之处,但稿件的资料来源、主要数据和图表相同或基本雷同;或 2 篇稿件在文字表达上连续有雷同字句,也视为抄袭。(3)凡来稿存在抄袭现象,我刊将不予以审理,而且将视情把稿件退给作者单位,并附寄稿件抄袭情况说明函。(4)凡来稿在接到回执或网上信息后的 3 个月内未接到修稿通知,则说明稿件在编委或专家的审理之中,若作者在此期间欲改投其他刊物,须及时告知编辑部撤稿,否则将视为一稿多投。

本刊编辑部